

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	口服給藥技術 Oral Medication Administration				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q05-W-A15	N10 陳依暄	89 年 01 月 31 日	115 年 04 月 07 日	115 年 04 月 07 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 04 月 07 日
版本/總頁數	第 4.0 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 04 月 07 日

一、目的

護理人員能正確操作口服給藥技術。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）技術目的

- 1.確實執行三讀五對，以協助病人依照醫囑，經口正確、安全的服下藥物。
- 2.預防、治療疾病或減輕症狀。
- 3.協助診斷。

（二）用物準備

- 1.藥盒。
- 2.核對電腦醫囑（HIS 護理系統）。
- 3.藥杯（或包藥紙）--視需要。
- 4.研磨鉢含杵。
- 5.藥匙--視需要。
- 6.吸管--視需要。
- 7.治療盤（放置藥水用）--視需要。

（三）步驟及要點說明

步驟	說明
1. 將給藥所須用物置於工作車台上	
2. 洗手	

主題名稱	口服給藥技術	制定單位	護理部
編號	A31000-Q05-W-A15	版本	第 4.0 版
		頁碼/總頁數	2/8

步驟	說明
3. 給藥時三讀五對： (1)從 UD 車或藥盒取出藥袋時，藥袋之<u>姓名</u>、<u>藥名</u>、<u>劑量</u>、<u>途徑</u>、<u>時間</u>與 HIS 系統護理執行之醫囑相符（一讀五對）。 (2)藥物自藥袋取出時，核對藥物與 HIS 系統護理執行之醫囑相符：<u>姓名</u>、<u>藥名</u>、<u>劑量</u>、<u>途徑</u>、<u>時間</u>相符（二讀五對）。 (3)藥袋放回藥盒前或丟棄前，藥袋再次與 HIS 系統護理執行之醫囑相符：<u>姓名</u>、<u>藥名</u>、<u>劑量</u>、<u>途徑</u>、<u>時間</u>相符（三讀五對）。	1. 應專心，不可與人說話，以免錯誤。 2. 五對：<u>姓名</u>、<u>藥名</u>、<u>劑量</u>、<u>途徑</u>、<u>時間</u>。 3. 未貼標籤、標籤模糊不清、變質變色、過期或潮濕的藥物勿使用。  4. 請逐字核對藥名字母以避免錯誤。 5. 核對藥物時，核對醫囑正確性應包含醫師指示欄之內容。 6. 核對後於 HIS 護理系統點選正確。
4. 若為水劑藥物，按口服水劑給藥法取藥 (1)取藥水方法： A. 檢查藥物有無變質，若有變質應立即更換。 B. 將藥物搖勻。 C. 打開瓶蓋，將瓶蓋內面朝上放置，避免染污。 D. 一手握藥瓶標籤處，另一手拿起藥杯，以大拇指按在所需劑量之刻度上，並應平視使此刻度與眼睛平行。 E. 將藥水倒入藥杯內所需之刻度。	1. 執行三讀。 2. 若為液態製劑，需檢查是否有變質。 3. 倒入藥杯前時需搖勻並看刻度。 4. 藥液需搖勻避免藥液內之溶質沉澱而影響劑量。 5. 平視才可準確看出藥杯上之刻度與藥液水平面是否同高。
(2)以滴計算藥劑法： A. 檢查藥物（液）有無變質。 B. 將藥液搖勻。 C. 打開瓶蓋，將瓶蓋內面朝上放置，再核對一次標籤。 D. 以滴管吸取所需之藥物劑量。 E. 於藥杯內倒少許的開水，滴管尖呈 45 度角，再將藥液滴入藥杯內藥液。	1. 執行三讀。 2. 目的：病人較易服下所需藥物劑量。 3. 若藥液不宜稀釋，可用拋棄式滴管直接滴入病人口中，滴藥時，宜滴於舌中間。
(3)藥物必需磨粉時： 將藥置於研鉢中磨碎，將藥粉置於包藥紙中包好並立即給予病人服用，研鉢使用後應立刻洗淨晾乾。	1. 避免將不同材質磨藥組的鉢、杵放在一起使用，以免磨出非藥物的成份。 2. 研鉢使用後應立刻洗淨晾乾，避免藥物殘渣於研鉢內。

主題名稱	口服給藥技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A15	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/8

步驟	說明
5. 藥物備妥後，將藥盒放回，準備發藥。發藥時間應遵照醫囑，以不超過 30 分為準（±30 分）。	1. 若準備好之口服藥物未立即執行時於執行給藥前，再次執行三讀五對之步驟。
6. 攜帶藥物至病人單位	1. 若是給予藥水，使用治療盤可以避免藥水溢出時，不小心沾到手的可能性。
7. 給藥前確認病人正確，再次核對執行給藥時「五對」： <u>姓名</u> 、 <u>藥名</u> 、 <u>劑量</u> 、 <u>途徑</u> 、 <u>時間</u> 。	1. 護理人員給藥前正確使用兩種以上辨識方法辨識病人：引導病人自述其姓名及第二道識別資料（如出生年月日、身分證字號等），無法應答者則由家屬(照顧者)說出姓名或核對病歷資料（床頭卡）並核對手圈。 2. 查核手圈檢查病人手圈資料是否正確：姓名、病歷號、及床號、若有轉床情形時是否有更改床號。 3. 床號非病人辨識項目。
8. 告知病人或家屬藥物之作用、副作用、注意事項及藥物可能產生之反應。	目的：建立病人安全感與取得合作。
9. 確定病人服藥之狀況。	強心劑如 Digoxin、抗高血壓藥物、胰島素、輕瀉劑等需檢視病人之情況再給藥，並於服藥後視察病人之反應。
10. 若病人可坐起，則協助其坐起吃藥；若病人不能坐起，則搖高床頭，病人臉側向護理人員。	發藥時若病人不在，則將藥物攜回待病人回來再給藥。
11. 倒開水（或使用吸管）協助病人確實將藥物服下。	1. 如病人需記錄出入量(I/O)，則所服用的水量應正確紀錄。 2. 一定親眼看病人服下藥物後，並與病人說話以確定服下藥物。 3. 病人吃藥後如有嘔吐現象需告知醫師視情況是否需補藥。
12. 若病人拒服藥物，應和病人討論拒服之原因，並告知醫師。	應於 HIS 護理系統點選拒服及護理紀錄上紀錄拒服原因。
13. 評估病人服藥後的感受、療效、副作用---等藥物之反應，以提供醫師開藥之參考。	若病人服藥後出現藥物副作用，應告知醫師，並於護理紀錄上紀錄。
14. 助病人恢復其舒適位置。	
15. 整理病人單位及工作車台面。	
16. 完成 HIS 護理系統執行狀態。若因故未能執行治療如預備出院、外出、嘔吐、拒服、NPO、檢查、病情改變、血糖（壓）改變、手術、腹瀉--	臨時醫囑給藥後 30 分鐘應確實評估。

主題名稱	口服給藥技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A15	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/8

步驟	說明
--等等，需將原因記錄於護理記錄上，並視狀況與醫師協商。	
17. 洗手。	

（四）注意事項

- 1.給藥前請確實三讀五對與病人辨識。
- 2.未貼標籤、標示模糊或過期之藥物切不可取用，應送回藥局更換。
- 3.患孩之口服藥可用滴管或杯子，較大之患孩能自己吞入藥丸則不必磨碎溶於水中，如為鼻胃管灌食病人需將藥片磨成粉狀溶於水中，而後灌入。
 - (1)嬰兒服藥時，切忌將藥物混入牛奶內，而造成嬰兒拒食牛奶及藥物之服用不準確。
 - (2)嬰兒服藥時切忌捏鼻子灌藥，以免灌入氣管。
 - (3)幼兒服藥若有 Digoxin 類之藥物，應與其他藥物分開服用；若服藥後有嘔吐情形應請醫師審視後再決定是否補藥。
- 4.用滴管滴藥時，宜滴於舌中間，注意勿使滴管碰到舌尖。
- 5.酸類、鐵劑及碘劑藥品應用吸管給服。
- 6.咳嗽藥水及胃乳不可稀釋，以免減輕藥效。
- 7.碘劑藥品需加入牛奶或果汁中服用。
- 8.油類藥品需冷服（加冰塊），並給予餅乾或果汁一起服用。
- 9.協助病人依藥物性質安排服藥順序：藥片、滴劑、胃乳、藥水、咳嗽糖漿。

（五）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

主題名稱	口服給藥技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A15	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/8

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 蘇麗智等合著(2021)・給藥法・基本護理學(下)(4版)・台北：華杏。
- (二) 曹麗英等合著(2024)・給藥法，新編基本護理學-學理與技術下冊(第4版)・台北：新文京開發。

七、附件

(略)

主題名稱	口服給藥技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A15	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
89.01.31	1.0	新制定	89 年 01 月 31 日 通過護理部技術標準委員會。
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.12.14	2.1	依據 100 年 11 月 3 日協調會議公告： 藥劑科住院調劑組公告自 100 年 12 月 01 日(四)起，住院口服藥品調劑方式全面由餐包改為總包調劑	100 年 12 月 14 日 通過護理部技術標準委員會。
101.11.28	2.2	步驟及要點說明 4.(3)新增：避免將不同材質磨藥組的鉢、杵放一起使用，以免磨出非藥物的成份	101 年 11 月 28 日 通過護理部技術標準委員會。
102.02.20	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
102.04.03	3.1	步驟 3.說明 1.新增五對：姓名、藥名、途徑、劑量、時間。 步驟 4.(3)說明新增：研鉢使用後應立刻洗淨晾乾，避免藥物殘渣於研鉢內。 步驟 13.說明新增：若病人服藥後出現藥物副作用，應告知醫師，並於護理紀錄上紀錄。	102 年 04 月 03 日 通過護理部技術標準委員會。
103.03.18	3.2	步驟及要點說明部份措辭修正	103 年 03 月 18 日 通過護理部技術標準委員會。
104.03.17	3.3	更新第六項參考資料	104 年 03 月 17 日 護理部技術標準委員會通過
104.09.29	3.4	第三項第(三)目步驟 3 說明新增：核對藥物時，核對醫囑正確性應包含醫師指示欄之內容。	104 年 09 月 29 日 護理部技術標準委員會通過
105.03.15	3.5	1. 第三項第(三)目更新 HIS 系統之醫囑核對五對順序：姓名、藥名、劑量、途徑、時間。 2. 增加步驟 7 說明： ➤ 無法應答者則由家屬(照顧者)說出姓名或核對病歷資料(床頭卡)並核對手圈。	105 年 03 月 15 日 護理部技術標準委員會通過

主題名稱	口服給藥技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A15	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/8

修正日期	版本	修正說明	備註
		➤ 床號非病人辨識項目。	
105.12.20	3.6	1. 原主題名稱：單一劑量口服給藥法；改為口服給藥法。 2. 更新目的及用藥準備之內容。 3. 更新第三項第(三)目之 3 備藥時三讀五對之步驟及說明內容。 4. 更新第六項參考資料。	105 年 12 月 20 日 護理部技術標準委員會通過
106.03.14	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.03.22	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.03.18	3.7	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 03 月 18 日 護理技術組會議通過；108 年 04 月 10 日 護理長會議通過；108 年 04 月 23 日 督導會議通過公布。
109.03.16	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.03.15	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.05.03	3.8	1. 說明(二)用物準備：新增 7.治療盤（放置藥水用）--視需要。 2. 步驟三(6)說明新增：1.若是給予藥水，使用治療盤可以避免藥水溢出時，不小心沾到手的可能性。	111 年 03 月 21 日 護理技術組會議通過；111 年 04 月 13 日 護理長會議通過；111 年 05 月 03 日 督導會議通過公布。
112.03.20	3.8	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	口服給藥技術	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q05-W-A15	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
113.04.16	3.9	第三項第三目步驟 4.(3)新增內容說明。	113 年 03 月 18 日護理技術組會議通過；113 年 04 月 10 日護理長會議通過；113 年 04 月 16 日督導會議通過公布。
114.03.17	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
115.04.07	4.0	1.主題內容「法」修訂為「技術」。 2. 第三項第三目步驟 4. (1)內容修訂。 3. 第六項參考資料修訂。	114 年 12 月 15 日、115 年 03 月 16 日護理技術組會議通過；115 年 03 月 18 日護理長會議通過；115 年 04 月 07 日督導會議通過公布。